

· 临床用药 ·

乙胺碘呋酮的药物相互作用

湖南省衡阳市核工业部 415 医院 邓万俊

乙胺碘呋酮是有效的广谱抗心律失常药物, 已经发现, 它能与许多药物发生有意义的相互作用。

一、地高辛: 药物代谢动力学研究证实, 乙胺碘呋酮可使地高辛半衰期延长 31%, 全身清除率下降 29%, 分布容积下降 11%, 血清地高辛浓度增加 69~100%^[1], 并可出现地高辛毒性副作用。这种相互作用在小儿尤为明显, 地高辛浓度可增加 70~800%。二者合用时, 地高辛剂量应减少 1/3 至 1/2, 并监测血清地高辛浓度。

二、华法令: 乙胺碘呋酮使凝血酶原时间明显延长, 增加华法令的抗凝作用, 甚至产生出血并发症。其机理是乙胺碘呋酮降低维生素 K 依赖性凝血因子的含量所致。这种相互作用的强弱与乙胺碘呋酮的剂量无关, 常出现在合并用药的第一周, 停药后, 相互作用尚可持续 4 个月。因此二者合用时, 华法令维持量应减半, 密切观察凝血酶原时间 3 个月^[2]。

此外, 乙胺碘呋酮亦能使肝素的抗凝作用增强。

三、抗心律失常药

1. 奎尼丁: 乙胺碘呋酮使血清奎尼丁浓度增加, 并可出现奎尼丁中毒, 机制不清。二者合用时, 奎尼丁剂量应减少 37%^[3]。

2. 普鲁卡因酰胺: 乙胺碘呋酮使普鲁卡因酰胺清除率下降 20%, 半衰期延长 39%, 分布容积不变, 血清普鲁卡因酰胺浓度增加, 并可出现普鲁卡因酰胺中毒。二者合用, 普鲁卡因酰胺剂量应减少 20%^[3]。

3. 利多卡因: 二者合用, 可引起窦性静止、逸搏心律^[4]。

4. 苯妥英钠: Gore 等报道 1 例乙胺碘呋酮使苯妥英钠血清浓度在 4 周内从 14.1 μg/ml 增至 41 μg/ml, 患者出现明显运动失调, 眼球水平震颤。停药后 4 周症状消失。推测是乙胺碘呋酮影响了苯妥英钠的肝脏代谢所致。二者合用, 苯妥英钠剂量应减少 50%, 并密切监测其血清浓度^[5]。

5. 茚满丙二胺: 乙胺碘呋酮可使茚满丙二胺血清浓度增加 52~60%, 持续 2~21 天^[6]。

6. 双异丙吡胺: 有报道二者合用可发生扭转型室速^[6]。

7. 氟卡因: 二者合用, 氟卡因血清浓度增加 5~190% (平均 60%), 持续 2~14 天, 因此合用时应将氟卡因剂量减少 1/3^[7]。

四、β 阻滞剂: 因二者均有负性肌力及负性变时性作用, 故合用时可引起心动过缓及窦性静止^[8]。

五、儿茶酚胺类药物: 二者合用可产生 α 及 β 受体阻滞作用^[9]。

六、钙拮抗剂: 乙胺碘呋酮与地尔硫革合用, 产生窦性静止及低血压, 有传导障碍及自律性异常者应用中更应慎重^[10]。

七、麻醉剂: 合用后出现心肌抑制, 心动过缓及肺部并发症等^[6]。

八、抗肿瘤药: 乙胺碘呋酮使抗肿瘤药的细胞毒性增强^[6]。

参 考 文 献

1. Moysey JO, et al. Amiodarone increases plasma digoxin concentrations. Br Med J 1981; 282: 272.
2. Hamer A, et al. The potentiation of warfarin anticoagulation by amiodarone. Circulation 1982; 65: 1025.
3. Saal A, et al. Effect of amiodarone on serum quinidine and procainamide levels. Am J Cardiol 1984; 53: 1264.
4. Kerdar S, et al. Sinoatrial arrest due to lidocaine injection in sick sinus syndrome during amiodarone administration. Am Heart J 1982; 104: 1384.
5. Gore JM, et al. Interaction of amiodarone and diphenhydantoin. Am J Cardiol 1984; 54: 1145.
6. Vrobel TR, et al. A general overview of amiodarone toxicity: its prevention, detection, and management. Progress in Cardiovascular Disease. XXXI(6): 393.
7. Shea P, et al. Flecainide and amiodarone interaction. J Am Coll Cardiol 1986; 7: 1127.
8. Oates JA, et al. Drug Therapy: Amiodarone. N Engl J Med 1987; 316: 455.
9. Brevetti G, et al. Amiodarone-induced decrease in lymphocyte beta-adrenergic receptor density. Am J Cardiol 1986; 57: 698.
10. Lee TH, et al. Sinus arrest and hypotension with combined amiodarone-diltiazem therapy. Am Heart J 1985; 109: 163.